

Asignatura: Salud del niño, niña y adolescente
SEMINARIO
Guía para estudiantes
2026



ENCUENTRO: ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA PREESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE

-Contenidos: Atención integral de la persona preescolar/escolar y adolescente: Historia clínica, examen físico completo, antropometría, IMC, desarrollo puberal, inmunizaciones, recomendaciones, evaluación oftalmológica, odontológica y auditiva. Percentilos de tensión arterial.

-Fecha: 20/04/2026

Objetivo General:

- Abordar la consulta integral de preescolares, escolares y adolescentes.

Objetivos Específicos:

- Abordar las problemáticas de la atención de la salud desde la perspectiva de la semiología, de variantes de la normalidad de los signos y síntomas de alarma y la derivación oportuna.
- Conceptualizar la Historia Clínica como la herramienta fundamental con énfasis en la anamnesis, la semiología y el examen físico.
- Realizar una correcta evaluación de los datos antropométricos (peso, talla) y saber utilizar las tablas de percentilos.
- Realizar correcta medición de IMC y TA. Saber utilizar sus tablas de percentilos.

- Evaluar el desarrollo puberal del adolescente. Reconocer el orquidómetro como herramienta de evaluación .
- Realizar derivaciones oportunas a especialistas (control oftalmológico, auditivo, odontológico, etc).
- Desarrollar habilidades en detección y comunicación de recomendaciones sobre alimentación saludable, prevención de lesiones no intencionales, medidas de higiene, derechos, deportes, sexualidad, etc. según la edad.
- Desarrollar habilidades de comunicación para brindar información adecuada y oportuna sobre la situación de salud del niño, niña y adolescente.
- Conocer los derechos y la legislación actual que respalda la consulta de una persona adolescente.

Bibliografía: Se usará la misma bibliografía que en el LHC de preescolar, escolar adolescente y además se agregará lo siguiente:

Bibliografía Obligatoria:

- Manual para la supervisión de la salud de niños, niñas y adolescentes. Comité nacional de pediatría general ambulatoria. SAP. 2010. pág 177-235.
- Omelanczuk, J., & Sturla, S. (2024). Control de ingreso escolar: un modelo de screening integral y multidisciplinario. Revista FASO, 31(3). Disponible en: <https://faso.org.ar/revistas/2024/3/1.pdf#:~:text=En%20el%20mismo%20documento%20elaborado%20por%20PROSANE%2C,ser%20identificado%20y%20referido%20para%20recomendar%20alg%C3%BAn.>
- Dei-Cas Pablo Gabriel: “Entrevista en el adolescente”, Pediatría en Red 3. Año 2020. pág 298-303.
- XIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente 2ª Mesa Redonda. José Valdés Rodríguez. Pediatra. Acreditado en Medicina del Adolescente. Alicante. EXAMEN FÍSICO DEL ADOLESCENTE
- MARCO LEGAL de la ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_sobre_derechos_de_adolescentes_para_el_acceso_al_sistema_de_salud.pdf
- D. Bueno i Torrens. El cerebro adolescente: época de cambio y transformación Director de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st. Facultad de Biología, Universitat de Barcelona - Adolescere 2023; XI (2): 78-83
- Manual para la aplicación de las Guías alimentarias para la población argentina (GAPA). Capítulo 1 . página 11-21
- FAO y OMS. 2020. Dietas saludables sostenibles - Principios rectores. Roma. Cuadros de páginas 12-13. Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/46a559db-2c90-4267-b1f8-c2218b126c46/content>
- La AEP actualiza sus recomendaciones sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia en base a la nueva evidencia científica. AEP. Diciembre de 2024. <https://www.aeped.es/actualidad/aep-actualiza-sus-recomendaciones-sobre-uso-pantallas-en-infancia-y-adolescencia>
- Libro verde. Curvas de percentilos de la SAP.

LOS ESTUDIANTES DEBEN TRAER RESUELTA LA GUIA

TRAER LAS HISTORIAS CLÍNICAS IMPRESAS PARA TRABAJAR Y TABLAS DE PERCENTILOS CORRESPONDIENTES (PESO, TALLA, IMC, Y TA)

Situación clínica 1: LIA

Concurre al consultorio Lia de 5 años y 2 meses con su mamá (38 años) y su papá (45 años)

Es una niña muy deseada por los padres, nacida luego de 1 aborto espontáneo ocurrido durante el primer trimestre. Tiene una hermana mayor de 10 años por parte paterna.

Viven ellos 3 en una casa de 2 pisos. En la vivienda hay 2 habitaciones. Tiene un baño. Agua corriente, un calefactor a gas. No tienen mascotas.

Es una niña nacida de 38 semanas de edad gestacional, con peso de 3.520 gr. Embarazo controlado. Refiere serologías maternas negativas. Alta conjunta. Meconio 24 hs. Caída de cordón a los 5 días. OEA normales (pasa ambos oídos). Eco de caderas normal. Prueba de Talón (FEI): normal. Screening oximetría de pulso: normal

Pecho exclusivo hasta el 3er. mes de vida, luego tomó leche de fórmula. Inició alimentación complementaria a los 6 meses.

Antecedentes: internación a los 9 meses por bronquiolitis, requirió oxígeno con bigotera 2 días. Se fue de alta a los 3 días.

Lia a los 3 años dejó los pañales, tiene una dieta selectiva (escasas verduras, pocos líquidos, come principalmente hidratos de carbono y lácteos) Nos comenta la mamá que la niña pasa varios días sin hacer caca, y cuando hace le duele o sale de a pelotitas.

Sedestación 6to mes. Caminó a los 14 meses. Sus primeras palabras fueron a los 10 meses. Colecho con ambos padres.

Asistió a guardería desde los 6 meses y concurre al jardín desde los 3 años: le gusta mucho ir, porque juega con sus compañeros. Actualmente está en sala de 5.

Lia es muy charlatana, conversa con todas las personas, su madre nos cuenta que come sola con cubiertos, que le encanta saltar la soga, sabe contar hasta 20, escribe su nombre, dibuja figura humana de 6 partes

En varias oportunidades durante la consulta, Lia se enoja ya que no quiere que la revisen y su papá la convence prometiendo luego comprarle golosinas.

Examen físico: Peso: 16,2 Kg. Talla: 103 cm. TAS: 90 mmHg TAD: 50 mmHg

Buen estado general. Conectada con el medio. Piel y faneras: sp.

Fauces sp. Mala higiene bucal. Presenta muchas caries.

Aparato cardiovascular: R1 y R2 en 4 focos, silencios libres, pulsos presentes y simétricos.

FC: 90 x min. TAS: 90 mmHg TAD: 50 mmHg

Aparato respiratorio: Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares sin ruidos agregados. Buena mecánica ventilatoria FR 20 x min.

Aparato gastrointestinal: abdomen blando, no doloroso, depresible sin masas palpables, sin visceromegalias. RHA positivos.

Aparato genital: prepuberal, sin particularidades (s/p).

Neurológico: Conectada, reactiva. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Marcha sin particularidades (s/p).

Agudeza visual: OD:10/10 OI: 10/10

Vacunas: tiene vacunas completas hasta los 24 meses.

1- Describa detalladamente los datos relevantes del relato. **Complete la historia clínica.** (PROSANE)

2- Realice el **genograma**

3- ¿Qué consideraciones tiene en cuenta al llevar a cabo el **examen físico** de la niña?

4- Percentile con las tablas del libro verde los **datos antropométricos** de Lia según la tabla que corresponda. Peso: 16,2 Kg. Talla: 103 cm.

5- Calcule el **IMC** y percentile

6- Enumerar las principales características del **desarrollo** de Lia. ¿Cómo las interpreta?

7- Al examen físico ud detecta que Lía tiene mal higiene bucal y nunca concurre al **odontopediatra** ¿En qué momento se realiza la derivación del niño/a al odontopediatra? ¿Qué pautas de higiene le recomienda?

8- Lia nunca concurre al **oftalmólogo**. ¿tendría que haber ido? ¿Cómo realiza el examen físico visual? Para realizar la agudeza visual ¿qué tabla se utiliza?

9- En el cierre de la consulta ¿cuales son las **recomendaciones generales** para la familia de Lia? En cuanto a la alimentación ¿considera alguna derivación?

10- Lia el año que viene pasa a primer grado ¿Que es el **PROSANE**? ¿Cuál es la importancia de los programas de pesquisa al ingreso escolar y qué controles se realizan? y ¿qué vacunas se indican?

SITUACIÓN CLÍNICA 2: Juan Ángel

Concurre a la consulta Juan Ángel de 15 años acompañado por su madre para control de salud. Su último control fue a los 9 años con otro médico pediatra. Al ingresar a la consulta, refiere que le gusta que lo llamen Juan y manifiesta su deseo de quedarse solo en la consulta.

Antecedentes personales: Recién Nacido de término, Peso Adecuado Edad Gestacional .No tuvo internaciones. No presenta antecedentes de alergia.

Antecedentes Familiares :

Padre fallecido en accidente vial el año pasado. Tenía 42 años

Madre: 40 años : sobrepeso, HTA

Abuelo paterno 73 años sobrepeso, hipertensión , diabetes tipo 2

Abuela paterna: 70 años: sana

Abuela materna: 65 años sana

Abuelo materno fallecido por ACV a los 68 años, el año pasado.

Vivienda: vive con su madre y su abuela materna en una vivienda con dos dormitorios. Tiene agua potable, energía eléctrica, gas envasado. Tiene su habitación propia, en la que pasa muchas horas encerrado

Escolaridad: Preescolar: desde sala de 3 años . Primaria completa sin complicaciones. Actualmente cursa tercer año de secundario en una Escuela Pública, hasta el año anterior había concurrido a escuela privada, pero lo cambiaron por no poder pagar la cuota. Buen alumno, sin dificultad en el aprendizaje. No realiza actividades deportivas fuera de las escolares, en la que realiza educación física 2 veces por semana 1 hora

Social: Ocupa la computadora 4 horas por día, usa redes sociales y juegos en red, y otros elementos tecnológicos: celular todos los días 4 horas, TV series los fines de semana viernes y sábado 2 horas. No tiene un grupo de amigos desde que comenzó en esta escuela.

Sueño: 7 horas por día y los fines de semana 10 horas

Alimentación: 3 comidas por día no desayuna sólo toma un té antes de ir al colegio, almuerza solo en su casa según refiere come fideos o salchichas, a veces hamburguesas. Merienda y cena las comparte con su madre y su abuela y en la cena la dieta es variada (carnes, verduras), durante el día Juan está muchas horas en la computadora y come pan, galletitas, snacks.

Imagen corporal: Refiere no sentirse conforme con su imagen y nos cuenta que en el colegio lo cargan.

Vacunas: Tiene calendario completo hasta los 6 años inclusive

Examen físico:

Piel blanco racial, aumento de panículo adiposo generalizado

Peso: 65 Kg Talla: 163 cm

Fauces: normales, piezas dentales completas en buenas condiciones

Otoscopia: Sin particularidades, audición impresionada normal

Agudeza visual OD 10/10 OI 10/10

Ap respiratorio: **FR: 14 x min** buena entrada de aire bilateral y simétrica sin ruidos agregados

Ap. Cardiovascular: relleno capilar < 2 seg. Pulsos periféricos positivos. Auscultación cardíaca: R1y R2 en 4 focos **FC: 75 x min TAS: 120 mmHg TAD 75 mmHg**

Abdomen: globoso blando, depresible, indoloro, ruidos hidroaéreos positivos sin visceromegalias.

Genitales: vello pubiano de características adultas . Volumen testicular de 20 ml bilateral

Maniobra de Adams: columna alineada sin signos de escoliosis

Aparato locomotor: normal Reflejos osteotendinosos: normales presentes y simétricos.

El año pasado salió unos meses con Romina, se conocen del barrio. Ella tiene 16 años, tuvieron relaciones sexuales, refiere que no siempre usaron preservativo. No consume alcohol, drogas o cigarrillos.

Últimamente se siente aburrido y no se está llevando bien con su familia.

- 1- ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué características tiene la consulta adolescente?
- 2- ¿Cómo continúa la evaluación del adolescente luego de la entrevista? Con qué frecuencia deben realizarse los controles durante esta etapa?
- 3- Cómo se realiza el examen físico en adolescentes? ¿Qué particularidades tiene ?
- 4- ¿Cuáles son los cambios en el desarrollo cerebral de los/as adolescentes?
- 5- ¿Cuál es el marco legal que refiere la atención de los y las adolescentes ?
- 6- Describa detalladamente los datos relevantes del relato. **Complete la historia clínica** de adolescente. Enumere las principales características del examen físico de Juan Ángel.
- 7- Percentile **peso y talla**. Calcule **IMC** y percentile.
- 8- ¿Cuáles son los signos de **desarrollo puberal** en varones y mujeres según Tanner? Calcule el **estadio de Tanner de Juan**
- 9-¿Cuál es la **técnica adecuada** de toma de TA?¿Desde qué **edad** realizamos la toma de TA? Juan tiene una **TAS: 120 mmHg TAD 75 mmHg Percentile. y Clasifique**
- 10- ¿Cuáles **vacunas** le indica a Juan?
- 11- ¿Qué **recomendaciones** daría a Juan y su familia? ¿Realiza alguna **interconsulta**?

PARA RESOLVER LAS PREGUNTAS DE LA GUIA

o N° 20

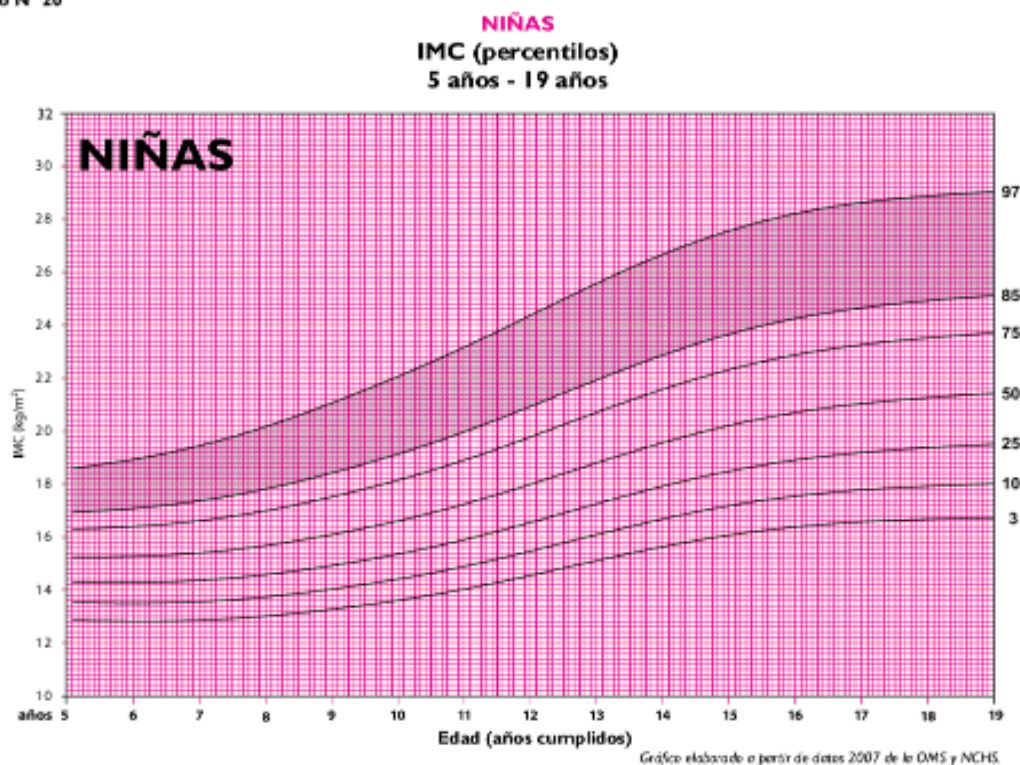


Gráfico N° 5

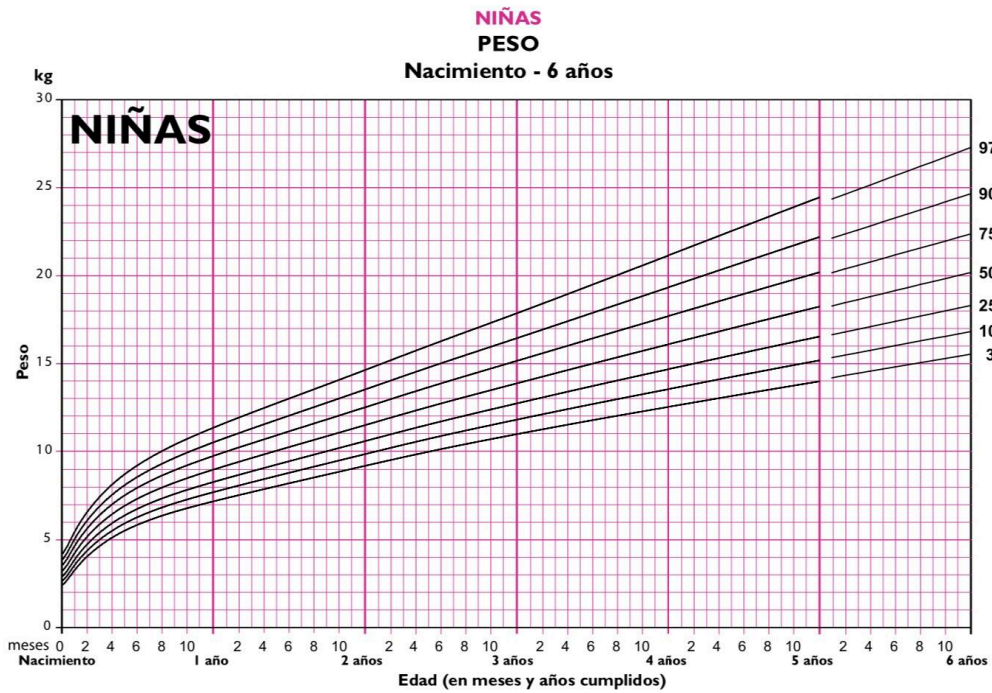


Gráfico N° 9

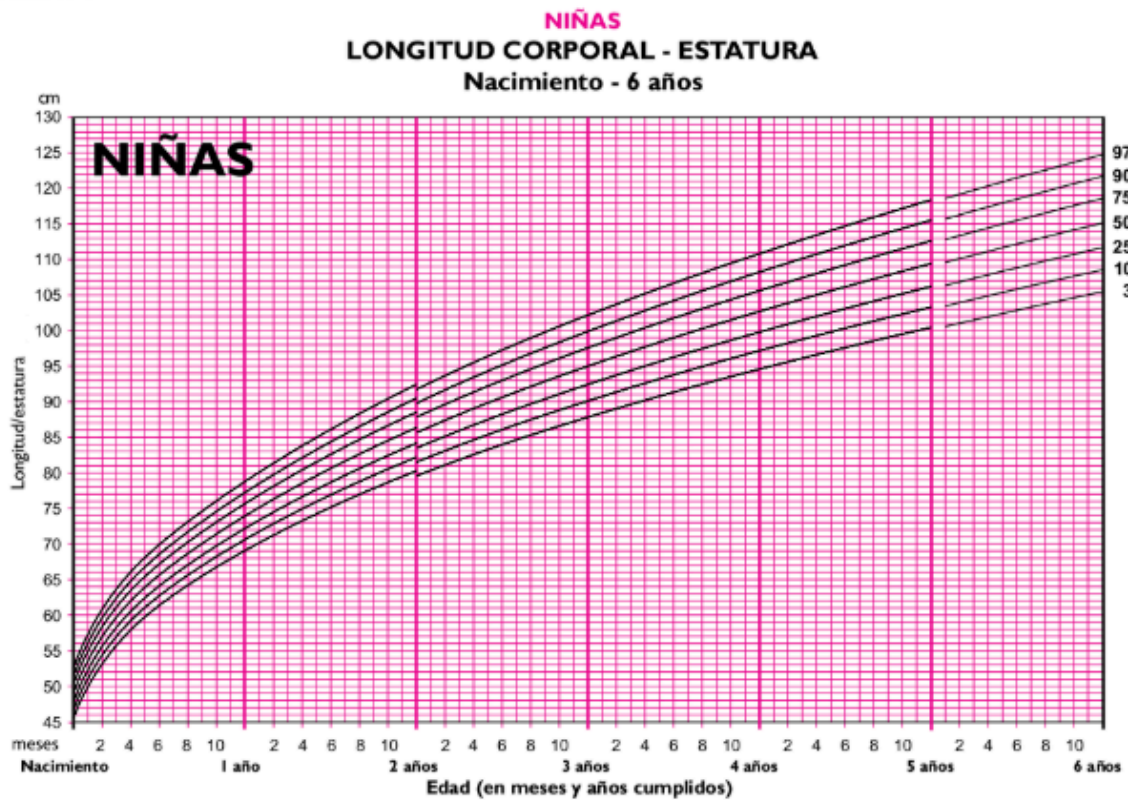
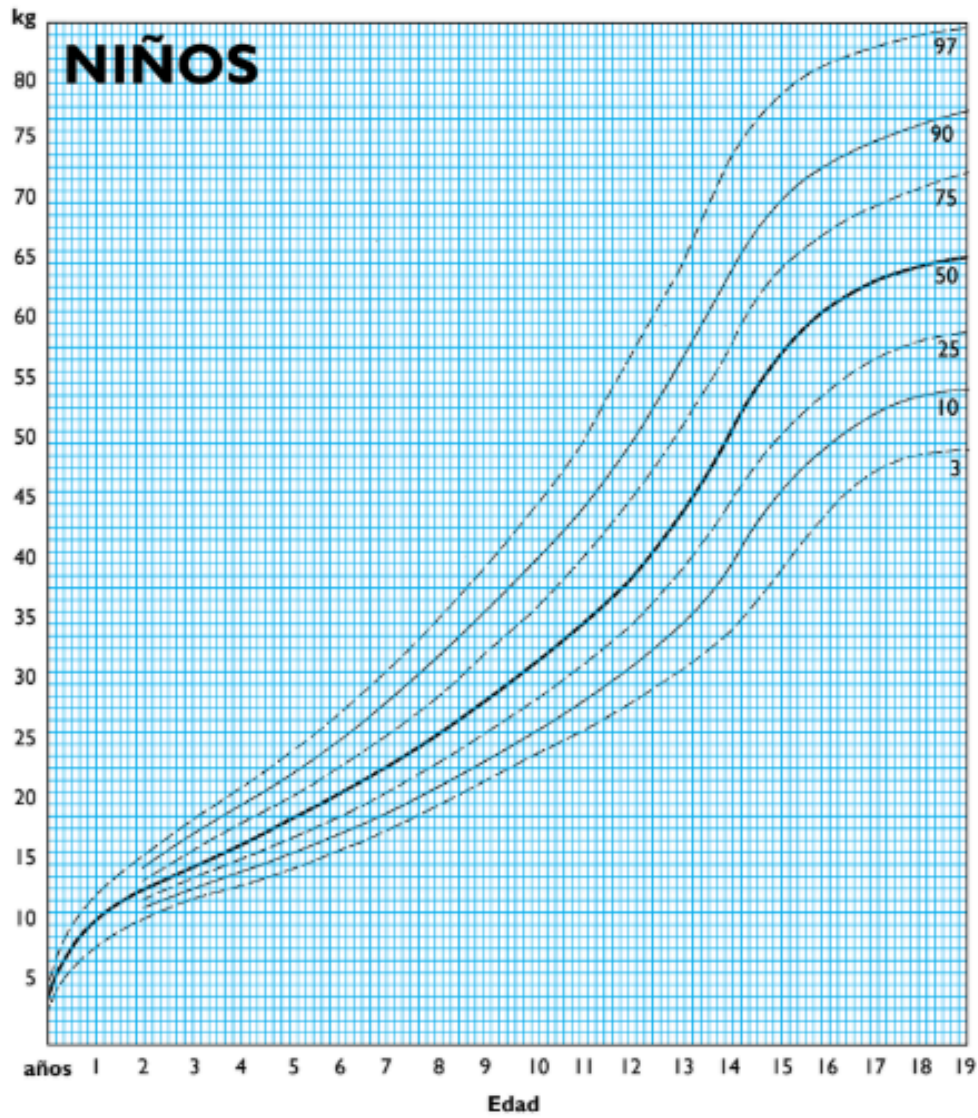
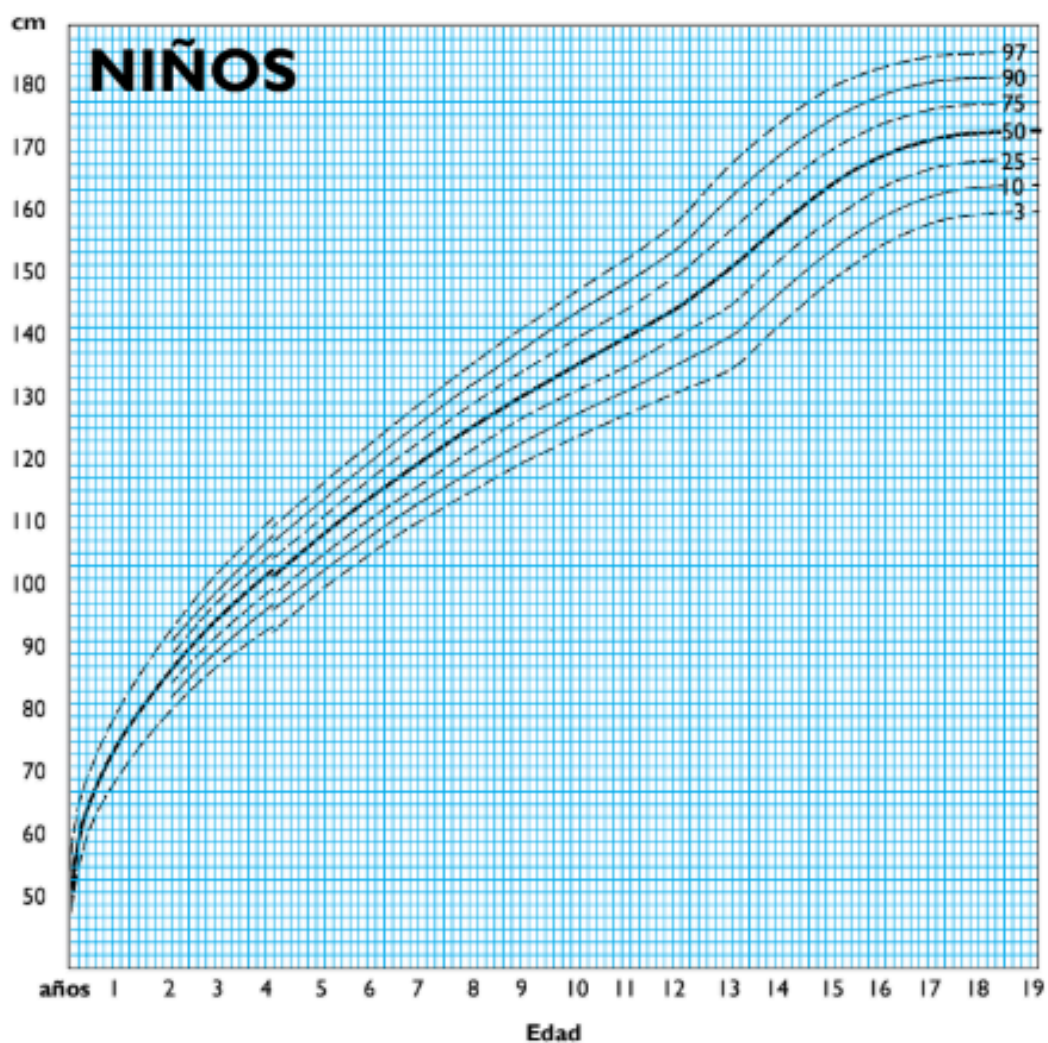


Gráfico N° 31

NIÑOS
PESO
NACIMIENTO - 19 AÑOS

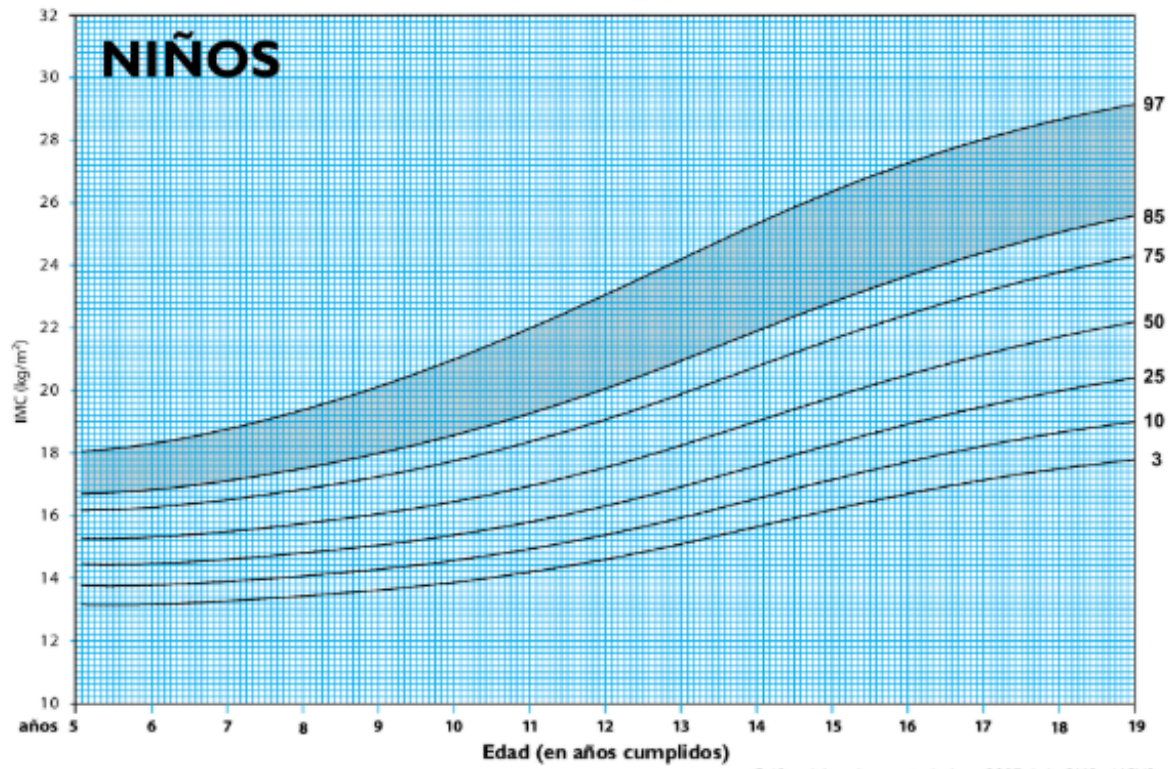


NIÑOS
ESTATURA
Nacimiento -19 años



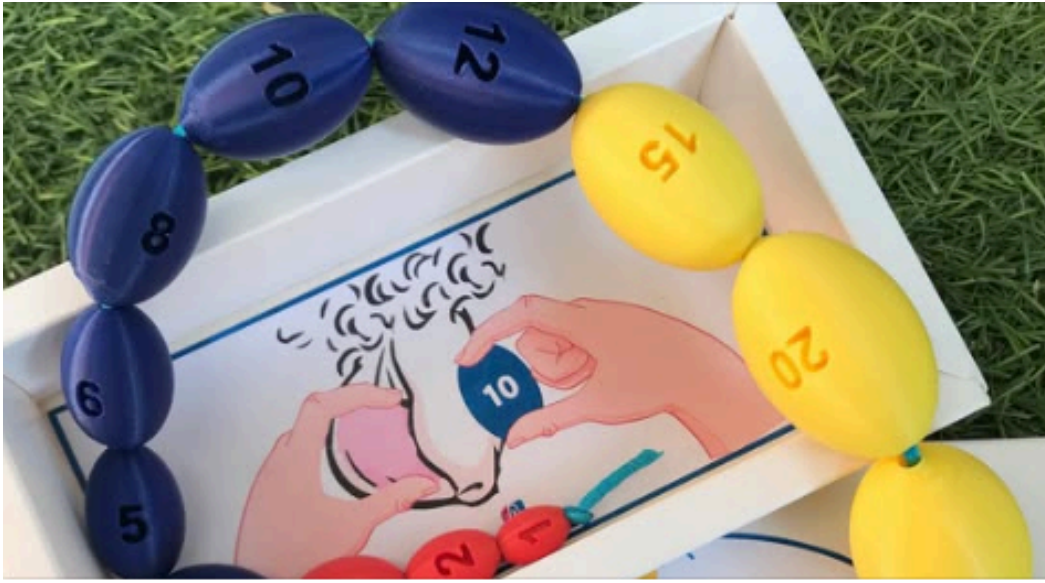
co N° 44

NIÑOS
IMC (percentilos)
5 años - 19 años



Continuación varones

Edad (años)	Percentilo Presión Arterial	Presión Arterial Sistólica (mmHg)								Presión Arterial Diastólica (mmHg)							
		Talla en cm								Talla en cm							
10		130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7		130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7	
	50	97	98	99	100	101	102	103		59	60	61	62	63	63	64	
	90	108	109	111	112	113	115	116		72	73	74	74	75	75	76	
	95	112	113	114	116	118	120	121		76	76	77	77	78	78	78	
	95+12mmHg	124	125	126	128	130	132	133		88	88	89	89	90	90	90	
11		134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6		134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6	
	50	99	99	101	102	103	104	106		61	61	62	63	63	63	63	
	90	110	111	112	114	116	117	118		74	74	75	75	75	76	76	
	95	114	114	116	118	120	123	124		77	78	78	78	78	78	78	
	95+12mmHg	126	126	128	130	132	135	136		89	90	90	90	90	90	90	
12		140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5		140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5	
	50	101	101	102	104	106	108	109		61	62	62	62	62	63	63	
	90	113	114	115	117	119	121	122		75	75	75	75	75	76	76	
	95	116	117	118	121	124	126	128		78	78	78	78	78	79	79	
	95+12mmHg	128	129	130	133	136	138	140		90	90	90	90	90	91	91	
13		147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4		147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4	
	50	103	104	105	108	110	111	112		60	60	61	62	63	64	65	
	90	115	116	118	121	124	126	126		74	74	74	75	76	77	77	
	95	119	120	122	125	128	130	131		78	78	78	78	80	81	81	
	95+12mmHg	131	132	134	137	140	142	143		90	90	90	90	92	93	93	
14		153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1		153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1	
	50	105	106	109	111	112	113	113		60	60	62	64	65	66	67	
	90	119	120	123	126	127	128	129		74	74	75	77	78	79	80	
	95	123	125	127	130	132	133	134		77	78	79	81	82	83	84	
	95+12mmHg	135	137	139	142	144	145	146		89	90	91	93	94	95	96	
15		159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2		159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2	
	50	108	110	112	113	114	114	114		61	62	64	65	66	67	68	
	90	123	124	126	128	129	130	130		75	76	78	79	80	81	81	
	95	127	129	131	132	134	135	135		78	79	81	83	84	85	85	
	95+12mmHg	139	141	143	144	146	147	147		90	91	93	95	96	97	97	
16		162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4		162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4	
	50	111	112	114	115	115	116	116		63	64	66	67	68	69	69	
	90	126	127	128	129	131	131	132		77	78	79	80	81	82	82	
	95	130	131	133	134	135	136	137		80	81	83	84	85	86	86	
	95+12mmHg	142	143	145	146	147	148	149		92	93	95	96	97	98	98	

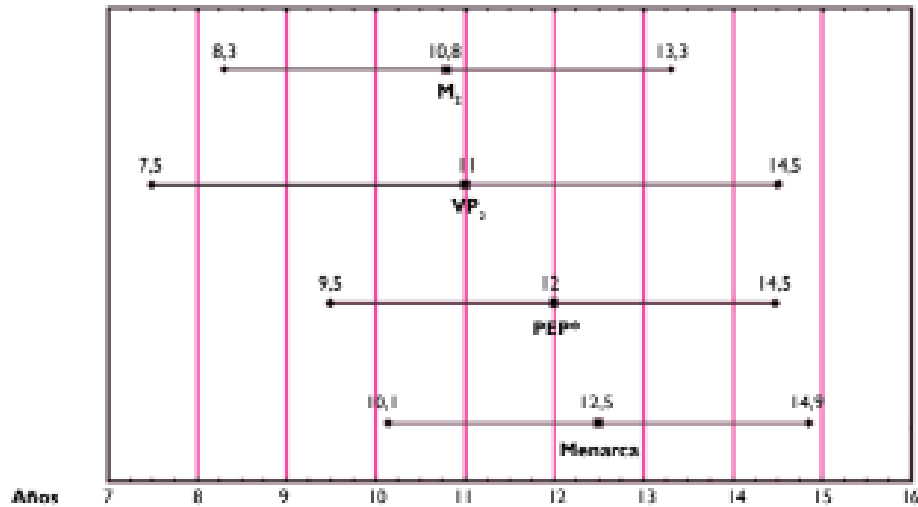


¿Cómo usar el orquidómetro de Prader?



Escala de Tanner	Tamaño testicular Orquidómetro de Prader
I	●●●
II	4 5 6
III	8 10
IV	12 15
V	20 25

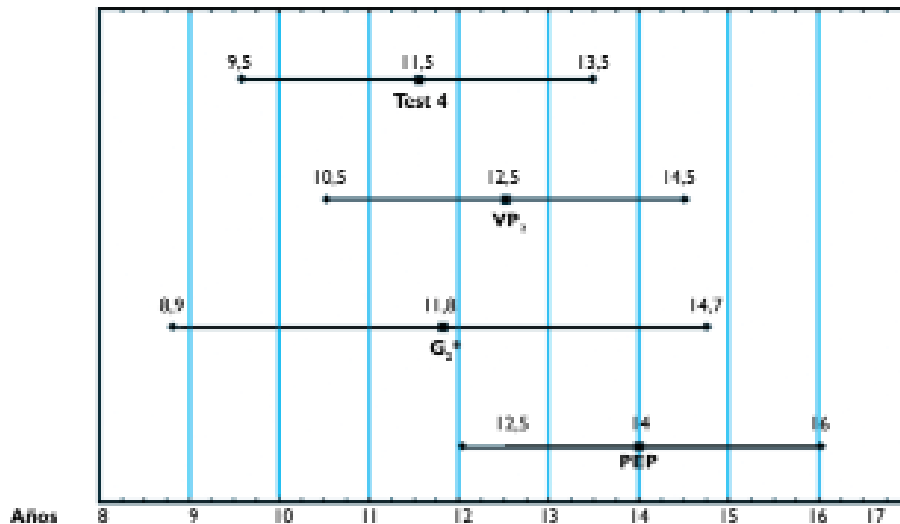
SECUENCIA DE EVENTOS PUBERALES. MUJERES*



M₂: Mamas 2; VP₂: Vello pubiano; PEP: Pico de empuje puberal.

Gráfico preparado por los Drs. Brelman F y Giersi V sobre datos de Lejarraga H, Sanchez J, Guzminsky M (Annals of human biology 1980; 7:589-81) para Menarca; de Lejarraga H, Castro E, Guzminsky M (Annals of human biology 1978; 5:379-81) para Mamas y Vello pubiano; y de Marshall WA, Tanner JM (Archives of Disease in Childhood 1969; 44:291) para Pico de empuje puberal.

SECUENCIA DE EVENTOS PUBERALES. VARONES*



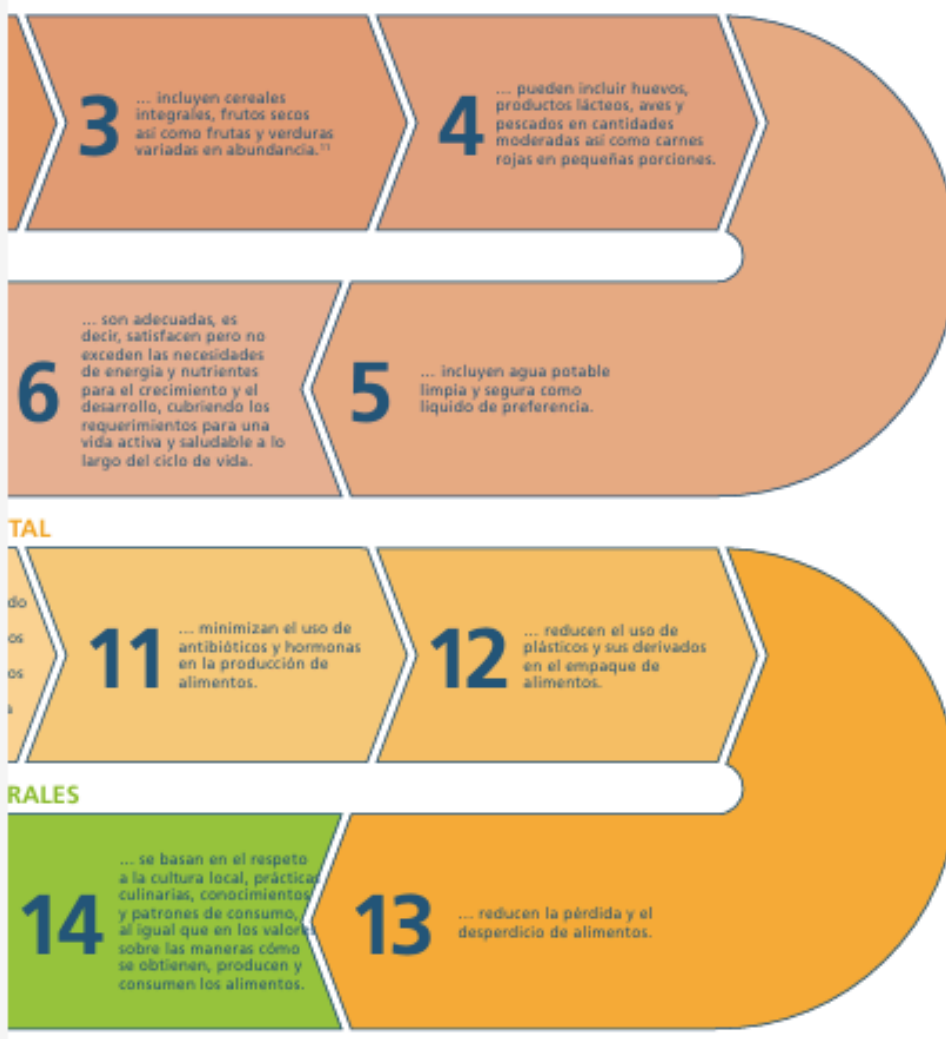
Test 4: tamaño testicular de 4 ml; VP₂: Vello pubiano 2; G₂: Genitales 2; PEP: Pico de empuje puberal.

Gráfico preparado por los Drs. Brelman F y Giersi V sobre datos de Lejarraga H, Castro E, Guzminsky M (Annals of human biology 1978; 5:379-81) para

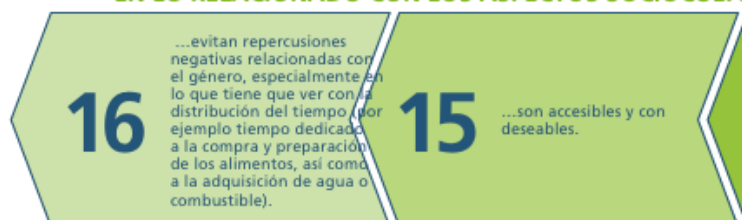
OBJETIVOS DE LAS DIETAS SALUDABLES SOSTENIBLES

Las dietas saludables sostenibles son patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas; tienen una baja presión e impacto ambiental; son accesibles, asequibles, seguras y equitativas; y son culturalmente aceptables. Los objetivos de las dietas saludables sostenibles son lograr un crecimiento y desarrollo óptimo de todos los individuos y apoyar el funcionamiento y el bienestar físico, mental y social en todas las etapas de la vida de las generaciones presentes y futuras; contribuir a la prevención de la malnutrición en todas sus formas (es decir, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad); reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación; y apoyar la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta. Las dietas saludables sostenibles deben combinar todas las dimensiones de la sostenibilidad para evitar consecuencias no deseadas.





EN LO RELACIONADO CON LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES



¹¹ El procesamiento de los alimentos puede favorecer la promoción de dietas de alta calidad y contribuir a la disponibilidad e inocuidad alimentaria. Sin embargo, algunas formas de procesamiento pueden conducir a elevar los niveles de sal, azúcar añadida y grasas saturadas que cuando son consumidos en altas cantidades comprometen la calidad de la dieta. (Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición. 2016. Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century. Londres, UK. <http://library.ipri.org/utis/getfile/collection/p15738coll5/id/5516/filename/5517.pdf>)